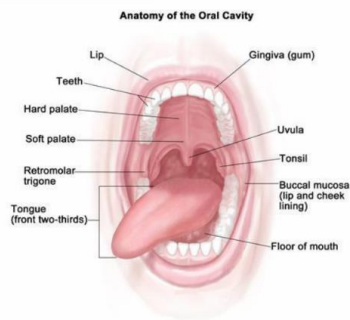




לאנטומיה והפיזיולוגיה של חלל פה היילוד יש תפקיד משמעותי מאוד מפני שהוא מניע את כל התהליך. לאנטומיה ופיזיולוגיה של התינוק יש תפקיד אקוטי ביכולת התינוק לינוק.

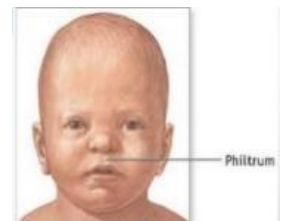
תקופה ארוכה התעלמו מכך שיש סיכוי שהבעיה בכלל לא נמצאת אצל האם ושבעיה עלולה להמציא אצל התינוק.

אם התינוק לא מפעיל טוב/נכון את מערכת היניקה שלו, גם אם לאם יש שפע חלב זה לא יעבוד. תיווצר בעיה רצינית ביכולת והמשכיות ההנקה.

פילטרום – איבר רפלקסיבי נמצא בין האף לשפה

מטרתו לסמן לתינוק אפה הפיטמה נמצאת, כאשר הפיטמה מונחת בנקודה זו ואז התינוק פותח את הפה.

רפלקס זה עובד עד גיל 4 חודשים לערך.



שפתיים

- שרירי שפתיים תקינים מאפשרים סגירה טובה שתמנע דליפה של מזון מחוץ לפה.
- השפתיים נפתחות בזמן חיפוש rooting מתי שהתינוק מתחיל לחפש.
- הפתיחה הכי אפקטיבית כאשר קיימת נגיעה בפילטרום.
- השפתיים מייצבים את השד בפה ומספקים לחץ תוך אוראלי.
- השפתיים חייבים להישאר יציבים במהלך היניקה.
- תנועת שפתיים מעידות על פיצוי תנועה לא נכונה של הלשון או יניקה שטוחה.
- Fish lips מעידות על יניקה שטוחה ולא תקינה. (כמו שתיה מקשית)

השפתיים הן הדלת, הסוגר כששפתי התינוק לא עובדות כמו שצריך, אין אטימה מספיק טובה. כשהשפתיים עובדות יותר טוב, האטימה על השד טובה יותר. לעיתים השפתיים מייצרות חסם שבא לתת פיצוי על תהליכים פיזיולוגיים לא תקינים. פשוט שמים את התינוק ליד השד והוא מנהל את זה לבד, הוא יודע לאיזה צד להתכוון. < כשניגע בלחי התינוק – הוא יפתח פה ויחפש.

תינוקות שיש להם בעיה במתח של השריר (היפוטוניה – טונוס נמוך, שרירים מאוד רכים/רפויים) פתולוגיה: תסמונת דאון - לסת נופלת, לשון מאוד גדולה – מריירים הרבה. ילדים שנולדים במלקחיים – יכולה להיות היפוטוניה זמנית – כתוצאה מלחץ המלקחיים בלידה. לא מצליחים לבצע אטימה אידיאלית. אין להם מספיק כוח לביצוע יניקה (פתיחת וסגירה)



השפתיים צריכות להיות משורבבות בצורה יעילה- לא חלש ולא חזק מידי יש צורך בטונוס תקין.

לפעמים מבנה של שד יכול לעזור לנו לעקוף את אחת הבעיות האלה. למשל אישה עם שד גדול שממלא את פי התינוק מאוד וזה מפצה על החולשה של השרירים הוא לא צריך להתאמץ.

שד גדול בתפיסת פוטבול – יכול לינוק גם אם יש לו היפוטוניה – כי הוא תפוס טוב.

הרבה מאוד פעמים אצל תינוק ללא פתולוגיה – מפעיל לחץ חזק של השפתיים – לפיתת השפתיים היא פיצוי על פעולה לא בשלה ממקום אחר.



לדוגמא – לשון קשורה – סוגרים שפתיים חזק . כשהתינוק משחרר השפתיים לבנות. יבלות – יניקה לא תקינה.

fishlips- כמו קשית- יניקה שטוחה ולא תקינה. אנחנו מצפים לראות שפה תחתונה מופשלת- אבל גם בשפתי דג יש הפשלה לכן צריך להנחות את האמא גם לראות שיש את הקריטריונים אבל גם להרגיש- אם כואב- לא תקין.

פה יותר רחב < חיבור יותר טוב < יכאב פחות. כל עוד בפה של התינוק הכל טוב.

התינוק לא יונק מהפטמה הוא יונק מהשד- אם יפתח את הפה מספיק והכל בסדר בפה ויכניס כמה שיותר- יכאב לך פחות. חשוב להבין שתינוק שזה עתה נולד- לא נצליח לראות בדיוק הכל מההתחלה, לעיתים צריך לבדוק שבועיים אחר כך או בתוך תהליך

לשון

הלשון היא השריר היחיד בגוף שלא מחובר משני צדדיו, ולכן יש ללשון מיתר שמחזיק אותה ואנחנו יודעים שבחלק מהפעמים יש בעיתיות והמיתר לא במקום.

הלשון, ומיתר המחבר את הלשון מאוד חשובים לתהליך היניקה. הלשון אחראית להכניס את השד לתוך הפה, מעצבת ומייצבת אותו בחלל הפה.

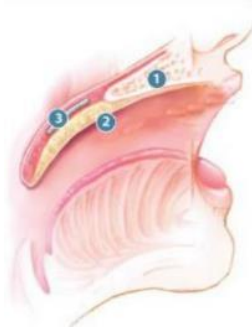
- לשון היא שריר מאוד חזק, היכול לבצע פעולה של חיתוך, הנשלט ע"י עצם הלשון.
- תפקיד הלשון לתמרן מזון כהכנה לבליעה. ליצור כדור (בולוס) וללעוס. המזון נכנס לתוך חלל הפה ואמור מתוך התנועה של הלשון להפוך לכדור. בזמן התנועה של הלשון יש הפרשה של בלוטות הרוק- גם חומר סיכה וגם מתחיל תהליך עיכול כבר בפה. בגלל שאוכלים מהר- בולעים ולא עוברים את תהליך התנועה המעגלית ולא מתחיל עיכול. אצל תינוק זה לא רלוונטי כי לא נכנס מזון אבל התנועות של הלשון חשובה ליניקה, יש ללשון הרבה מאוד מיומנויות



- על הלשון יש עצבים תחושתיים, מוטוריים ובלוטות טעם המאפשרים לגוף לדעת מה הוא בולע. בלוטות הטעם – פזורות באופן אחיד על חלל הלשון ולא לפי איזורים. המערכת העצבית מגיבה קצת אחרת לכל טעם (חמוץ/מר/מלוח..).
- הלשון מורכבת מתאי אפיתל פשוטים ותאי אפיתל קשקשיים (מפרישים) – למטרות הגנה וחושיות. הלשון היא גם הגנה- המוח יודע על ידי הבלוטות מה הוא עומד לבלוע והוא ידע לירוק- רפלקס דחיסת הלשון. מאוד פעיל אצל תינוקות קטנים כדי שלא יחנקו. הלשון הינו כלי הגנה, מערכת ויסותית – אם נכנס משהו לפה שעלול לסכן אותי. (חרף, מלוח) – משהו לא תקין נכנס לגוף.

בולוס - הלשון עובד כמו מכונת כביסה – המזון נכנס לחלל הפה באמצעות הלשון מתכדרר (הפרשה מבלוטות הרוק – חומר סיכה שמתחיל את תהליך העיכול) – הלשון מניעה את המזון. בגלל שאוכלים מהר – אנחנו בולעים – רוב העיכול לא מתחיל בפה. אצל יונק זה לא רלוונטי. - אצל יונק יש תנועה ותזוזה של הלשון שדוחפת את המזון .





1 – חך קשה- עצם
2 – חך רך
3 – רקמה סחוסית

חך

חלל הפה = ריצפה של הגולגולת, והיא מושפעת ממבנה של הלשון .
החך מתחיל בעצם עבה ולאט לאט העצם צר יותר..

כשילדים נולדים – הפה מורכב מלשון – כשהלשון דוחפת את החך הקשה.
חלק פנימי חך רך – כדי לאפשר למזון לעבור לחלל הפה.

חך קשה

שתי עצמות שהתחברו ויוצרת את תקרת הפה ואת רצפת הגולגולת
כשתינוק נוצר הפה שלו הוא בעיקר לשון ובשלב האמבריטי הלשון לוחצת ויוצרת את הצורה של הפה.
לעיתים שתי העצמות לא מתחברות כמו שצריך

- החך הקשה hard palate הוא החלק הקידמי של החך.
 - החך הקשה מורכב מעצמות המחוברות במפרק פיברוטי (מפרק צמוד).
 - העצמות המרכיבות אותו הן הזיז החכי של הלסת העליונה, הנמצאת בקדמת החך הקשה, והחלק האופקי של עצם החך הנמצאת מאחוריו.
- זה אומר שיש חלל מעל העצם.
כשיש חור בחך- האוויר נכנס לפה או שנוזלים ומזון נכנסים לחלל האף.

חך רך

החלק הפנימי הוא חך רך כדי לאפשר לאוכל להכנס לוושט.
חלק פנימי – רפלקס ההקאה – חך רך ללא עצם.
כשנכנס מזון דוחף כלפי מעלה ומאפשר למזון להיכנס פנימה.



מונע מעבר מזון לחלק הפתוח (לקנה נשימה העליון)
ענבל – קשור למערכת הגנה החיסונית שלנו. לא יודעים עד הסוף להסביר מה הייעוד שלו.

- החך הרך soft palate הוא רקמה רכה המכסה את אחורי גג חלל הפה.
- הוא נמצא בין החך הקשה לבין הענבל ונבדל מהחך הקשה בכך שבניגוד אליו אין בו עצמות.
- החך הרך הינו איבר נייד המצויד בסיביי שריר העטויים קרום רירי.

תפקידו של החך הקשה הוא לסייע בייצוב והחזקת הפיטמה בפה.
המיקום של הפיטמה יושפע מהלחץ שמופעל מהחך הקשה
החך הרך יוצר ואקום – פועל עם הלשון על מנת ליצור אטימה של חלל הפה.
חלב יוצא מהפיטמה כמו פופמה- על ידי וואקום.

החך הרך עולה בזמן הבליעה , נוגע בלוע וחוסם את מעברי האף ומסייע לבלוס לנוע לעבר בית הבליעה.
החלל (חלל האף) מעל הפה - הוא מעל העצם. כשיש חור בחך עובר אויר/מזון , כמו חך שסוע.





- חך גובה
- חך שטוח
- חך צר
- חך ארוך / קצר
- V חך בצורת
- חך בועתי
- חך מדורג
- חך תעלתי

מבנים חריגים של חך

מבנה חך קשור למבנה של הלשון.
למבנה החך יש השפעה משמעותית על מידה הכאב של האמא ועל היניקה.
מבנה החך קשור באופן ישיר למבנה הלשון.
ברוב הפעמים נראה מקרים שלא יספיק רק להתיר את הלשון צריך גם אוסתאפתיה.

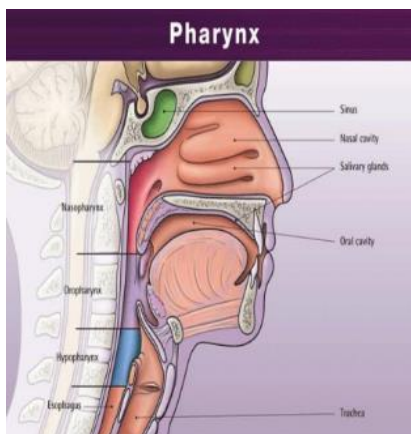
פרנאלום Frenulum

הפרנאלום היא ממברנה המחזיקה ומעגנת את הלשון לרצפת הפה.

פרנאלום קצר או ממוקם קדימה מידיי – מיתר קצר – טווח תנועה של הלסת מתקצר < ועלול למנוע תנועה חופשית של הלשון למעלה וקדימה < גורם לבעיות הנקה.
מיתר רחב – נוטה להוריד את הלסת יותר מטה – מיתר יותר ארוך פה יותר רחב.



ככל שהתינוק יפתח פה רחב יותר החיבור יהיה טוב יותר והשד יכנס בצורה אידיאלית.



לוע – פרינקס Pharynx

הלוע הוא צינור שרירי מרופד בקרום רירי שנמשך מתחילת הוושט עד לבסיס הגולגולת והוא מחולק לשלושה חלקים:

- לוע גולגולת nasopharynx
- לוע עליון oropharynx
- לוע תחתון hypopharynx

צורת הלוע משנה מאוד כשהילד גדל בלידה הלוע פונה כלפי מטה כדי להתאחד עם החלל הפה.

החך הרך למעשה עושה מעבר בין חלק נשימתי לבלעתי.

כשנעשה בולוס החלק של החך הרך עולה מעלה וסוגר את המעבר – והמזון עובר פנימה לתוך הרשת.

העצם הזו גדלה.

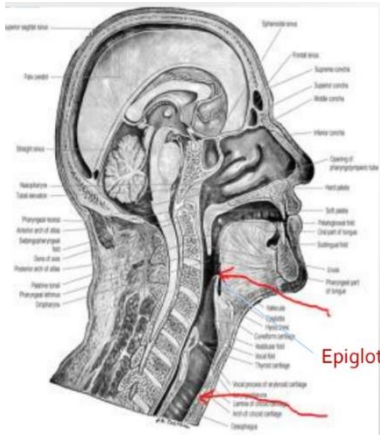
לקראת גיל 11-12 שבועות תינוק מכניס ידיים לפה לגרות מוח – תינוק דוחס את החך הרך והקשה כלפי מעלה- ומכין אותו לשלב האורלי הבא.

זו פעולה ניוירולוגית שמכין את התינוק למעבר למוצקים. עם הידיים הם דוחפים את החך ודוחקים את רפלקס ההקאה אחורה השלב הבא בטווח גיל ה- 4 חודשים - מעבר לאכילת מוצקים.



גרון Larynx

- איבר האחראי למעבר אוויר מין הלוע אל הריאות. הוא נמצא בקדמת הצוואר מעל קנה הנשימה
- הוא עשוי תשעה חלקי סחוס ביניהם בלוטות התריס מכסה הגרון (= epiglottis אפיגלוטיס).
- קשור יחד על ידי רצועת שרירים ומרופדים בקרום רירי ובתוכו נמצא זוג מיתרי הקול.
- גרון התינוקות גבוה ותופס יותר מקום משל מבוגר, הוא קצר ובצורת משפך, כשנוזלים עוברים בפה, הגרון מתרומם כדי שהנוזלים יוכלו לנוע בקלות יותר אל הלוע בזמן הבליעה.



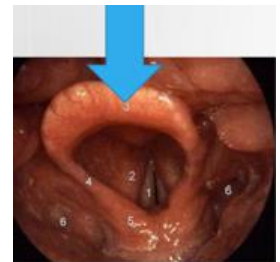
אחד אחראי על מזון (לוע) השני אחראי על אוויר (גרון) – נמצאים אחד ליד השני

האפיגלוטיס - מכסה הגרון.

רקמת סחוס דקה המכוסה קרוב רירי שנמצאת מאחורי שורש הלשון ומחוברת לשאר מבני הגרון באמצעות רצועות השריר



מכסה הגרון סוגר את המעבר מקנה הנשימה אל האף בזמן הבליעה ובכל מונע שאיפת מזון.



- האפיגלוטיס של התינוקות ממוקם ממש מתחת לחך הרך (בניגוד למבוגרים) מה שמאפשר למזון לעבור הצידה להיכנס ישיר ללוע.
- יש לו תפקיד חשוב בחסימת הניתב לריאות בזמן הבליעה < חלב עובר ללוע ולא לקנה הנשימה.

בעת הבליעה הוא סוגר את הקנה. בהקאה עולה הקיא לאף – כי המערכת נסגרת לא נכון < נסגרת הפוך. אצל תינוק הלשון נוגעת בחך – אצל מבוגר יש חלל אוויר בין לשון לחך.

אצל תינוקות עם ריפלוקס יש גם בכי צרוד, כיון שהאפיגלוטיס לא נסגר כראוי.

החך הרך סוגר את החלל העליון ומכסה הגרון סוגר את החלל תחתון (לכיוון הריאות) וכך נוצר צינור שבו עובר המזון. בבליעה – חך רך עולה כלפי מטה, האפיגלוטיס עולה מעלה – והמזון עובר במסלול סגור ללוע.

אספירציה - כניסת מזון לתוך הריאה. עלול לגרום לדלקת ריאות.

כניסה של מזון לתוך הריאה כי האפיגלוטיס לא נסגר כמו שצריך או שנסגר ונפתח. או בניתוחים- אם לא בצום האוכל עולה למעלה והאפיגלוטיס נסגר הרי הפוך.

בשונה מבקבוקים- אם יש אספירציה של חלב אם- זהו נזל פיזיולוגי שמתפרק בעילות ולכן חוץ מחוסר נוחות רגעית והישרדותית – השתעלות להוציא את החומרים אין דלקת ריאות. אם יש אספירציה של פורמולה היא מסוכנת כי יכולה לגרום לדלקת בריאות.

כניסת תרכובת חלב לריאות – עלולה לגרום למוות.



מרכיבי החלב בנויים בצורה כזו שאחת הדברים הכי חשובים זה לשמור על מערכת העיכול שלנו- החלב מעודד פרוביוטיקה. בתוך כל מערכת העיכול יש פרוביוטיקה שמפרקת את החומצה של הקיבה שהיא ממש אכזרית. בתוך חלב אם יש מזון ליחידים הטובים האלה. האיבר היחיד שלא מקבל פרוביוטיקה הוא הוושט, כי החלב לא שווה שם הרבה. כל זמן שיש חלב במערכת יש שגשוג של החיידקים.

המקום היחיד שלא מגיע אליו חלב האם - הוא הוושט. ממנו סובלים ריפלוקס, צרבות, אי נוחות. הוושט היא בסיסית ולא חומצית אבל גם בסיס חזק יכול ליצור צריבה.

הטבע אומר- כשהתינוק נח ולא מעכל חלב אני אדחוף בחזרה את המרכיבי החלב מהקיבה במעלה הוושט- החלב יעלה וירד ויעלה וירד וכך יזין את הפרוביוטיקה בוושט. הפרוביוטיקה בתוך הוושט תשגשג.

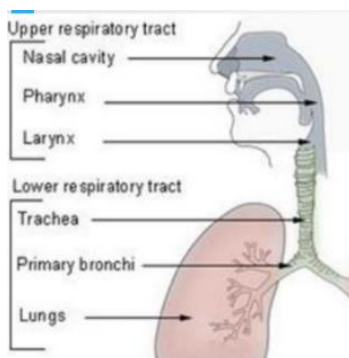
תינוק צריך שיהיה לו ריפלוקס סמוי כדי לגן על הוושט.

1% מהאוכלוסייה- מצב פיזיולוגי בו המערכת מעלה חומצה (מיצי קיבה) ולא חלב אם – זה מה שמכונה ריפלוקס אמיתי. אם תינוק ניזון על פי לוחות זמנים או ניזון או משלב תרכובות חלב < ריפלוקס במקרה זה הינו ריפלוקס אמיתי כי אז מה שעולה למעלה זה לא חלב אם אלא מיצי קיבה האם אלא שמייצרים את הריפלוקס. תינוק שיונק על פי דרישה הקיבה שלו תמיד מלאה תמיד יש חלב אם במערכת והחלב עובד על עוד דברים חוץ מהזנה.

ריפלוקס סמוי זה בסדר ותקין - תהליך פיזיולוגי תקין. ואפילו חיובי. במהות אין דבר כזה ריפלוקס סמוי.

מנגנון השובע אומר זה יותר מדיי בשבילי (התינוק)- הוא פולט את זה החוצה. – אם עליה תקינה ובעיית הפליטה היא עקב האכלה מעבר לקיבולת הפליטה באה לאזן כמויות ואין בעיה. ואם אין עליה מספקת – כנראה יש בעיה נירולוגית (הסוגרים לא נסגרים נכון, סתימה בוושט וכד' - פתולוגיה)

תינוק עם לשון קשורה – אחוזי ריפלוקס גבוה. לשון קשורה אחורית – דוחפת חלק שרירי וסוגר את הלוע – הלשון לא נמצאת כמו שצריך מפעילה את טריגר ההקאה. שחרור לשון קשורה – הטבה בבליעה.



קנה הנשימה Trachea

• קנה הנשימה הוא צינור המתחיל בגרון, צולל לאורך הצוואר אל בית החזה ומתפצל לשני סמפונות שענפיהם מעבירים את האוויר לריאות.

• הקנה עשוי מ 15-20 פיסות סחוס שעוטפות אותו כמעט לכל אורכו.

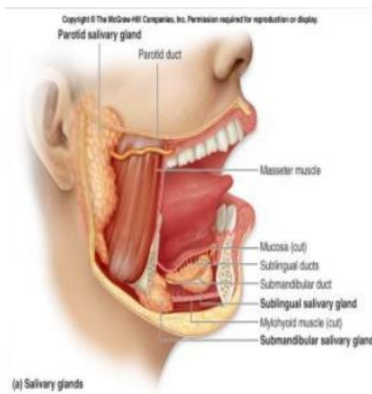
אצל תינוקות בשנה הראשונה מאוד רכים – וילכו ויבשילו עד גיל שנה. < בנוי מ 9 סחוסים.

רוב התינוקות אם עולים היטב במשקל ועושים רעש (של צפצוף) של קנה הנשימה זה נראה לרינגומלציה= השרירים לא בשלים וזה יעבור.

אם תינוק לא עולה במשקל – צפצופים אלה – נובעים מהריאות. לכן ההבחנה היא לרוב אם תינוק לא עולה במשקל – ישנה בעיה.



בלוטות רוק

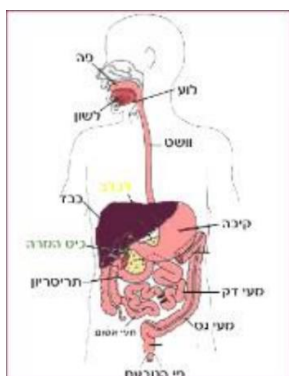


- בלוטות בגוף המייצרות רוק נזל השומר את לחות הפה וחלקים אחרים של מערכת העיכול.
- הרוק מסייע לפירוק המזון ומחליק על ידי סיבוכ, את ירידת המזון מהלוע אל הוושט וממנו אל הקיבה.

אין לתינוק יכולת לשלוט על ריור.
תינוקות עם היפוטוניה בלסת – לא מצליח לבלוע רוק – קורה לפני גיל 8 שבועות.

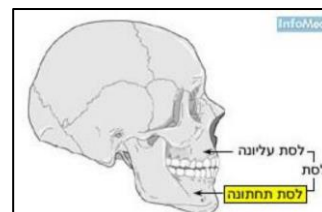
יש ריור יתר מגיל 8 שבועות כי יש המון רוק והם עוד לא יודעים לבלוע אותו
לקראת גיל 8 שבועות מתחילים להכניס את הידיים לתוך חלל הפה- מכניס חידקים, הריר בא להגן ולמנוע כניסת חיידקים לחלל הפה.
ליפאז ועמילאז מכינות את המערכת כמנגנון הגנתי - מפרקות את החידקים והריר הוא לשם הגנה.

וושט Esophagus

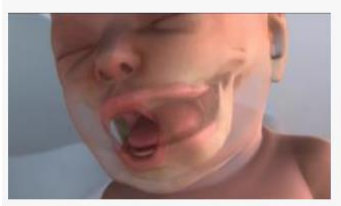
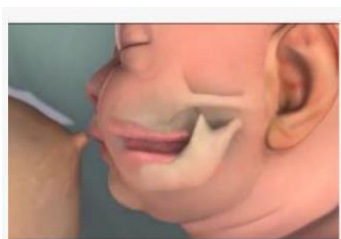


- צינור שרירי בעל דפנות המצופות בקרום רירי המחבר את החלק התחתון של הגרון.
- הוושט מרופד בקרום רירי שהפרשתו מסייעת למזון שנבלע לעבור מן הפה אל הקיבה.

לסת תחתונה Mandible



- עצם דמוית פרסה שהמשטח העליון שלה נושא את השיניים התחתונות.
- הענפים האנכיים שלה מופרקים עם עצם הרקה ויוצרים את המפרק הלסת הרקתי.
- בשנה הראשונה הלסת התחתונה גדלה לכיוון מטה ומגדילה את חלל הפה.
- הנקה אפקטיבית מעודדת את גדילת הלסת התחתונה (מנדיבולה) ומחזקת את שרירי הלסת.



- תנועה ריתמית של פתיחה וסגירה מסיים ללשון לייצר את הלחץ השלילי שסייע בשחרור החלב.
- ככל שיש מפתח פה רחב יותר < ייווצר יותר ואקום > יימשך יותר חלב. (כמו פומפה) פה גדול יותר וכל התומכים מסביב תקינים < הזרקת החלב טובה יותר. ואקום נותר מתנועת הלשון.
- אצל התינוק הלשון והלסת התחתונה פועלים בסנכרון.

לסת יורדת לשון יורדת ולהפך < יש פעולת סנכרון.
במצבים שיש לשון קשורה- הלסת יורדת מהר והמיתר קצר ומושך מהר את הלשון ומאיץ את הנפילה של הלשון ונוצר קול תקתוק כי הלשון נותנת מכה, נקישה על הלסת.
גם אם יש הרבה מאוד חלב – שומעים את הרעש הזה במספר שאיבות ראשונות של התינוק.



- אם הלשון לא מתפקדת באופן מלא/טוב הלסת התחתונה והשפתיים ינוע בצורה לא נורמלית על מנת לסייע לחלב לזרום. זה מפצה על החוסר של תנועת לשון תקינה.
- זה לא אומר שאם אפתור את אחת הפתולוגיות כל הבעיות יפתרו.
- בלוטת התריס לא מתפקדת – עלולה לגרום לפיגור.

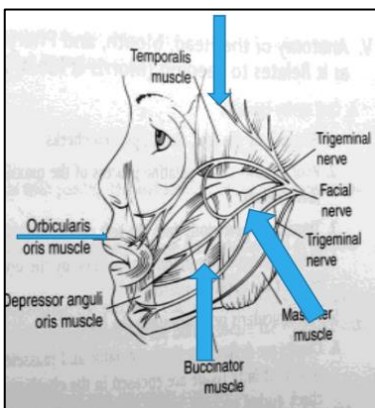
Buccal fat לחיים

- השומן בחלל הפה מהווה את הגבול ללשון ומסייע בייצובה.
- הם עוזרים להמשכיות חליבה ועוזרים למניעת קריסת הלחיים ושרירי הלחיים אל בין החניכיים.

הלחיים יוצרים לחץ תוך אוראלי בזמן היניקה. אצל תינוקות שאין מספיק שומן בלחיים כאשר הם יונקים יש קריסה של הלחיים פנימה. אם יש את הקריסה אפשר להעריך שהוא לא מעביר חלב. היכולת של התינוק לעשות את התנועה של הוואקום היא פחות טובה. לפגים אין שומן בפנים – הם לא מצליחים לשמור על התנועה. ולא מצליחים לייצר את הלחץ הנדרש.

השרירים המעורבים ביניקה

מלא שרירים, זו קואורדינציה של פעילות שרירית ענפה. המערכת הזו עטופה במערכת עצבים



- Temporalis – מעלה את הלסת התחתונה, סוגר את הפה, מושך את הלסת התחתונה אחורה.
- Masseter – סוגר את הלסתות.
- Buccinator – דוחס את הלחי.
- Orbicularis oris – סוגר את השפתיים.
- Mentalis – מעלה את מרכז השפה העליונה.

12 עצבים סימטריים אחראים על עצבוב הפנים תפקיד נוירולוגי- תפקודי תנועתי ותפקיד תחושי

אם הגולגולת זזה במהלך הלידה- מה שקורה, יכול לקרות מצד שהעצמות ילחצו על המערכת העצבית והתפקוד של עצב ספציפי אחד או יותר ירד. או תקלה עצבית תחושתית- כואב, או תקלה תנועתית. אוסטיאופט מחזיר את המרפסים למקום כדי לשחרר את המערכת העצבית.

5 העצבים הקרניאלים החשובים לבלעיה

Glossopharyngea העצב ה-9
עצב הלשון והלוע מעצבב את השקדים הלוע ואת 1/3 האחורי של הלשון (סעם)

VAGUS העצב ה-10
תפקידו לעצבב את הקרביים מפעיל את המערכת העיכול הפרסטלסית ולא מעט תנועות שרירים בפה, כולל דיבור ושמירה על הגרון פתוח לנשימה

hypoglossal עצב 12
מוביל לשרירים של הלשון הוא שולט בתנועות לשון של דיבור, מניפולציות מזון ובלעיה.

trigeminal עצב 5 (CN5)
אחראי על תחושה בפנים ולתפקודים מוטוריים מסוימים כמו לנשוך וללעוס.

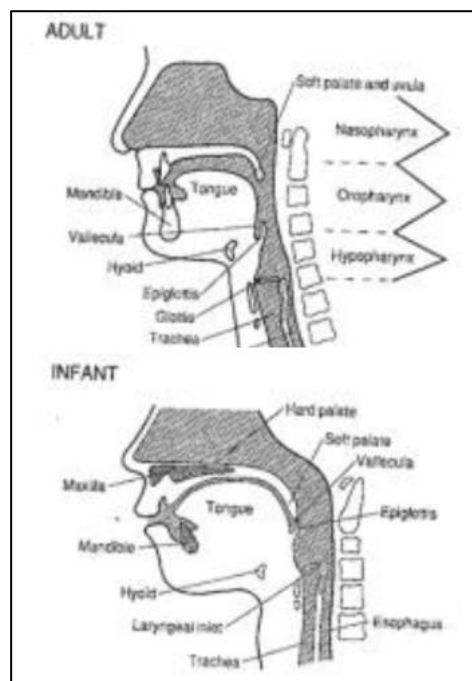
Facial עצב 7 (CN7)
עצב הפנים אחראי על שרירי הבנוות הפנים, ושולט על פונקציות בשיוע של תחושות סעם מזוני השלישים הקדמיים של הלשון וחלל הפה.

- לידת מלקחיים – יושב על עצב 7 – ויוצר חוסר תחושה.
- עצב 10 – מפרע ויוצר בעיות בעיכול.



שוני במבנה הפה בין מבוגר ותינוק

- פה התינוק קטן באופן משמעותי ביחס למבוגר.
- כשהפה סגור הלשון נוגעת בחניכיים ובגג הפה.
- לסת התינוק (המנדיבולה התחתונה) קטנה יותר ומעט נסוגה אחורה.
- חך התינוק קצר, רחב וקשתי במעט עם הלידה.
- לחיים עוזרים לינוק, ולהחזיק את השד בפנים במשך ההנקה בגלל שלשון התינוק ממלאה את חלל הפה < כיוון תנועת הלשון מוגבלת.
- ניצני בלוטת הטעם נמצאות בלשון כבר מלידה (לרוב בקצה הלשון)
- אבל לתינוק יש תגובת מציצה מוגברת רק לטעם מתוק.
- שפתי התינוק מותאמות היטב ויוצרות סגר אוויר מסביב לשד הן מעט מופשלות החוצה כך שהריר שנמצא בחלל הפה יוכל לצאת.



אצל תינוק חלל הפה בעיקרו הוא לשון - מרכז הפה מוחזק ע"י לשון.
אצל מבוגר הלסת והאף באותו קו והלשון הלכה מעט אחורה ובאמת יש "חלל"
חך גבוה - לשון לא טובה < מעיד על כך שהלשון לא יושבה במקום הנדרש)
מיתר קשור) בשלב האמבריאוטי.
על מנת להכניס את הפטמה לפה - חייב לפתוח את הלסת רחב מאוד -
להנקה אפקטיבית.

רפלקסים.

תינוקות יוצאים אל אוויר העולם מצוידים ברפלקסים שמיועדים להרגיל את התינוקות אל העולם החדש. הרפלקסים מתבטאים בתגובות אוטומטיות לגירויים חיצוניים שונים.
רפלקסים נועדו על מנת לסייע לתינוק להתמודד עם העולם.
לרפלקסים אלה יש ערך הישרדותי עבור התינוק.
רפלקסים מותאמים לשלב ההתפתחותי של התינוק - חלקם מלווים את התינוק גם בהמשך חייו, חלקם ייעלמו לגמרי או יהפכו לתגובות גופניות רצוניות ומשוכללות יותר ויותאמו לסיטואציה ההתפתחותית בה התינוק נמצא.

בתפיסה תינוק נולד טרם זמנו.
היינו אמורים להיות כמו פילות - תינוק אמור לצאת פעוט < משמע הוא יוצא ממש לא בשל.
לכן הרפלקסים עוזרים לתינוק להתמודד עם העולם החיצון.

דוגמאות:

נשימה - רפלקס שילווה את התינוק לכל אורך חייו.
הליכה - תינוק נולד אתו וקיים עד 12 שבועות. לאחר מכן נעלם לו רפלקס זה - ובעתיד יחזור < משהו שיצטרך להשתמש בו.

יש 2 קטגוריות לרפלקסים אוראליים Oral reflex

1. רפלקס פרודקטיבי - הגנתי Protective
2. רפלקס אדפטיבי - הסתגלותיים/מותאמים Adaptive

רפלקס החיפוש - Rotting - בזהה למצפן.

מניע תהליך ראשוני של הנקה.
כשנוגעים בשפתי התינוק או בלחיו הצד אחד, הראש יסתובב לאותו כיוון בניסיון לתפוס את פטמת השד.

מופיע בגיל 32 שבועות בשלב האמבריאוטי. (תינוק שנולד בשבוע 29 - רפלקס זה לא קיים עדיין - והרפלקס לא מתפתח).
תינוקות לא רוכשים אותו. מעט מאוד אולי יצליחו (מאוד נדיר).



יכול להעלים בין 3-6 חודשים. ומשתנה בין תינוק לתינוק. לא קשור למשקל, קשור למיומנות. העדר (אם לא קיים לתינוק הרפלקס) או רגישות יתר (נגיעה בלחיים יותר מידי) – יכול לפגוע בהנקה.

רפלקס המציצה - Sucking - חשוב ביותר

רפלקס הישרדותי החשוב ביותר. גורם לתינוק למצוץ במרץ דבר שנוגע בפיו. (כמו פטמה, מוצץ, אצבע). ביחד עם רפלקס החיפוש מאפשר לתינוק לינוק מיד עם היוולדו.

אם הוא לא מתקיים לרוב הפתולוגיות מאוד משמעותיות ובעיות < מעידות על בעיות נירולוגיות קשות.

עובד רק אם לא מגרים את רפלקס ההקאה. רפלקס הישרדותי חשוב – רפלקס ההקאה עובד יותר מהר מרפלקס המציצה. נשים עם פטמות גדולות – כידוע פטמה מתארכת פי 2.5-2 גודלה – עלולה להפעיל את רפלקס ההקאה (רפלקס הגנתי) החזק מרפלקס המציצה. עלול להגרם גם ממוצץ.

מופק ע"י גירוי או לחץ בלשון ובחיבור בין החך הקשה לחיך הרך. נעלם בין 15-18 שבועות.

מרווח הריונות לפחות 18 חודשים - כל הפחות מזה – עלול לגרום לתינוק להיוולד משקל נמוך ממשקל הלידה/ פגים. בלידה אגרסיבית אין אפקט מציצה – אחד מהעצבים נפגעו – עצבים קרינאליים (ללשון). גם בלידות מלקחיים – פוגע בעיצוב בלשון.

פגים:

32 שבועות של יניקות אך ללא קואורדינציה – המון השתנקויות. 34-35 שבועות – מסוגלים לינוק לפרקי זמן קצרים.

רפלקס הבליעה Swallowing

מופק ע"י מגע הבולוס עם הרצפטורים הסנסוריים של החלק האחורי של הפה. בולוס – החומר שנוצר בתוך חלל הפה. – תפקיד חשוב ביותר במערכת הקרנאלית.

בין שבוע 12-14 בשלב האמבריאוטי – וויסות כמות מי השפיר בהריון. התינוק בולע את מי השפיר ומשתין אותם. עודף פחות מטריד אך עדין מצריך בדיקה. חוסר במי שפיר - גרוע יותר – הוא בלע? מדוע הוא לא הוציא מצד שני – מעיד על בעיה! לקראת הלידה העובר בולע כחצי מכמות מי השפיר מידי יום.

בגיל חודשיים, פעולת האכילה הופכת לרצונית, המציצה והבליעה אמורות להפוך לתנועות רצוניות. בתוך תהליך הבליעה יש תהליך רצוני ותהליך לא רצוני.



רפלקס ההקאה Gag

רפלקס ההקאה הוא רפלקס התכווצות של החלק האחורי של הגרון, מעורר ע"י נגיעה בגג הפה בחלק האחורי של הלשון, באזור סביב השקדים.

אצל תינוק, המערכת היא יותר קדמית כי הפה יותר גובה והלשון תופסת יותר מקום – הרפלקס נמצא קידמי מאוד. לקראת גיל 4 חודשים – עם גדילת הראש – הרפלקס הופך להיות יותר אחורי – הכנסת ידיים לחלל הפה.

מופיע בשבוע ה-18 להריון – בשלב האמבריאוטי.

נדחק לקראת גיל 4 חודשים.

ככל שרפלקס ההקאה נדחה לאחור – יש מוכנות מצד התינוק לאכילת מוצקים.

רפלקס דחיקת הלשון protrusion

לפני רפלקס ההקאה – רפלקס דחיקת הלשון.

תינוקות נולדים על רפלקס זה, המגן עליהם מבליעת חפצים וחנוק.

מוכנות לאכילה תתבטא בין השאר בהיעלמות של רפלקס זה.

נעלם בגיל 4-5 חודשים.

תינוק מסוגל להכניס מזון מבלי שיפעיל לו את הרפלקס להוציא דברים החוצה.

רפלקס הנשיכה

רפלקס הנשיכה גורם לתינוק לנשוך באופן אוטומטי אצבע המוכנסת לפיו.

בגיל חודשיים פעולת האכילה הופכת רצונית, המציצה והבליעה אמורות להפוך לתנועות רצוניות.

מופיע בשבוע 28 להריון – בשלב האמבריאוטי. ונעלם לקראת גיל 9-12 חודשים והופך לרצוני.

מופעל אם יש לחץ בין החך העליון לתחתון.

כשניגע לתינוק בחך התחתון – ייסגר את הפה

הלשון גורמת לשמירה על כך שלא ייסגר הפה.

תינוקות עם לשון קשורה ינשכו. כי הלשון לא מונעת את הסגירה.

אם רפלקסים לא נעלמים זה אומר שיש פתולוגיות ספציפיות.

מהי בליעה?

בליעה היא תהליך העברת מזון או נוזלים מהפה דרך הלוע והוושט ועד הקיבה. זהו תהליך מורכב ומעורבים בו עצבים, שרירים,

רפלקסים, בלוטות רוק ובלוטות טעם.

• אנו בולעים בממוצע 600 פעם ביום.

• בכל בליעה 1-2 סמ"ק רוק.

• הבליעה היא אירוע המתרחש תוך הפעלת לחץ ועצירת נשימה

למשך 1/3-2/3 שניה.

• מיד עם סיום הבליעה אנחנו פולטים מעט אוויר (בלתי נשלט)

כהמשך למנגנון ההגנה.



שלב 1- השלב האוראלי הפומי.

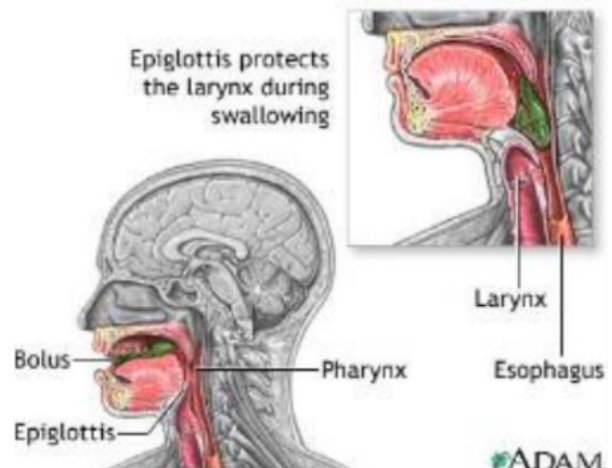
שלב הפיכת המזון לבולוס.

- שלב זה מתחיל עם הכנסת המזון לפה.
- הלשון מעבירה את הנוזל/מזון אל החלק האחרון של הפה והופכת אותו לכדורון bolus.
- בהמשך היא לוחצת את הכדורון אל החך הגרמי ומעבירה אותו לאזור השקדים.
- חך גרמי = חך קשה. שם מופקת הבליעה.
- חלק זה נחשב לשלב רצוני המנשך כ 8-10 שניות הנשימה נמשכת – מערכת הנשימה פתוחה.

פומי – כדור.

שלב 2 - השלב פרינגאלי – לוע.

- הבולוס עובר ללוע דרך שער הלוע.
- שלב חצי רצוני העורך כשנייה.
- החך הרך עולה לאחור וסוגר את המעבר לאף.
- מתחילות תנועות סחיטה בלוע הדוחפות את הכדורון כלפי מטה.



שלב 3- השלב הוושטי.

- מהרגע שמופק רפלקס הבליעה ועד הכניסה לוושט – שניה אחת או פחות.
- המעבר בוושט נמשך בין 8-20 שניות.
- שלב בלתי רצוני לחלוטין.

בליעה- תינוקות

- בליעה נצפתה בגיל 10-11 שבועות לחיי העובר
- מציצה מסוג suckling בין 18-24 שבועות
- אצל פגים בגיל 27-28 שעות תנועות בודדות – אין מיומנות מציצה.
- בין השבועות 30-33 מציצה מאורגנת יותר – התפרצויות של מציצה והפסקה ביניהן

תנאים בסיסיים לאכילה מוצלחת

1. מערכת נשימה יציבה.
2. יניקה חזקה וקצבית.
3. תאום מלא בין מציצה-בליעה-נשימה.

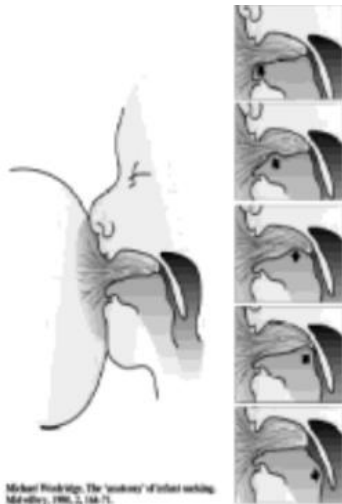
שאלה למבחן

המדע של מציצה ובליעה Science of suckling/sucking

- משימה רב מימדית של תאום מושלם ודינמי בין מציצה, בליעה ונשימה.
- מונחים המסבירים תנועת הפה כאשר לא תמיד יש הבחנה ברורה בין השניים.



מכניזם של היניקה.



- התהליך בו מתאורת ניקוז החלב מהשד והעברת החלב לתינוק.
- לחץ שלילי בחלל הפה - ואקום VACUUM.
- לחץ חיובי – לשון כלפי הפטמה כלפי החך.
- תנועה מעגלית של הלשון כלפי מטה.
- לחץ מוגבר בצינורות.

וואקום הוא לחץ שלילי- פומפה. נוזל בתוך צינור- עם הוואקום נמשוך אותו החוצה לחץ חיובי- לחץ חיצוני שמהלחץ הנוזל יוצא החוצה.

- הפטמה וחלק מהחלק התחתון של העטרה נמשכים עמוק פנימה לתוך פה התינוק, שפתיו ולחיו של התינוק אוטמות סביב. שפתי התינוק מופשלות החוצה ותפקידם ביניקה מינימאלי.
- קצה לשון התינוק נשארת מאחורי השפה התחתונה ומעל החניכיים בעוד ששאר הלשון חופנת את שאר העטרה של השד. כשהתינוק רוצה לינוק הוא מכניס את הלשון בין החניכיים שלו. ככל שהלשון יותר החוצה פחות אפשרות לנשיכה. הנשיכה עלולה לקרות כשהוואקום משתחרר והלשון הולכת אחורה

במהלך היניקה הפטמה האלסטית של האמא מתארכת פי 2-3 בעקבות המציצה והלחץ שנוצח הפה התינוק. הפטמה מתארכת ומגיעה לחלק האחורי עד לצומת בין החך הקשה לרך. בשלב זה הפטמה מוחזקת בין החך העליון והלשון שמכסה את החך התחתון. הלסת מזיזה את הלשון למעלה ולוחצת את העטרה כנגד alveolar ridge של התינוק.



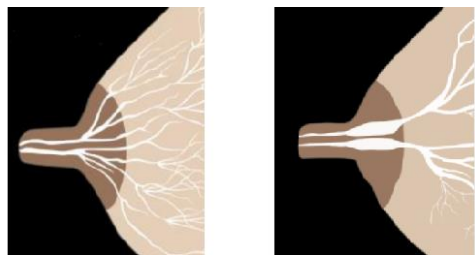
חך עליון נוגע בתחתון – לסתות נסגרות (אפקט התנין)
כשהתינוק רוצה לינוק הוא מוציא לשון – ואז נוצר הפרדה .
לשון יותר החוצה הסיכוי שתינוק ינשך נמוך.
הפטמה אמורה לשבת בין החך לרך הקשה.

להרחיק קנה והוושט, וכשהראש לאחור זה מאפשר להזרקת החלב לרדת ישר ללוע. < אין בזבוז של חלב לחלל הפה.
הרחקה – ויסות של פעולת הזרימה – מצר את הצינור וההזרקה איטית יותר.
40 שניות לדקה וחצי – הזרקת החלב.

וואקום פנים אוראלי ולא תנועה מעגלית של הלשון יוצרים את הזרמת החלב.
לואקום יש תפקיד מרכזי בהעברת החלב
הלשון לא חזה בתנועה מעגלית החלק לא נסחט מהצינורות
המחסור בתנועה מעגלית מראה שהפטמה נשארת כל הזמן באותה



מחקרים חדשים מראים שינויים במבנה האנטומי של השד.



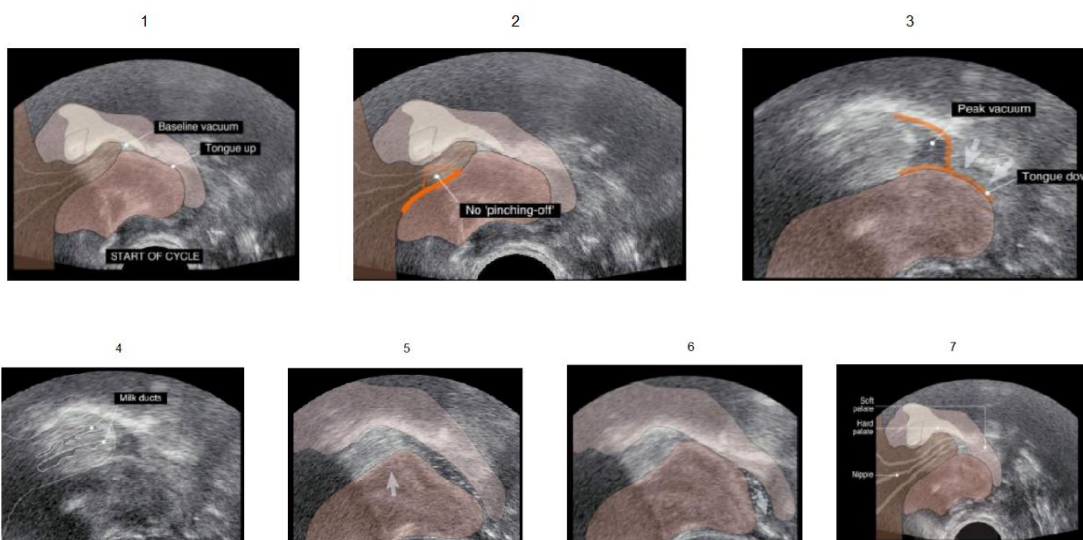
השינוי המשמעותי הוא מצב בו לא קיימים כבר צינוריות חלב lactiferous duct

lactiferous duct - צינורות שאוספות את החלב ונפתחות באזור הפטמה.
lactiferous sinus - המשך של lactiferous duct - מרכז את החלב ממש לפני היציאה מהשד.

באמצעות שימוש באולטרסאונד שמוקם במרכז הפנים של התינוק, נמצא ש:



1. כאשר מתקיימת יניקה, החלק האחורי של הלשון נדחס כלפי מעלה.
2. הלשון לא לוחצת את צינורות החלב בתנועה מעגלית
3. אלא נוצר ואקום כאשר הלשון יורדת בחלקה האחורי כלפי מטה ונותר חלל המאפשר שחרור חלב
4. ניתן לראות שצינוריות החלב מתרחבות ומאפשרות זרימה של חלב לחלל
5. כאשר החלב משתחרר, הלשון עולה מעט < כך שהחלב יוכל לזרום לעבר החך הרך.
6. הלשון עולה שוב לעבר החך הרך והחלב זורם לעבר הלוע
7. קצה הפטמה לא נוגע במעבר בין החך הרך לחך הקשה
8. אין הוכחה לכך שהלשון זה בתנועה מעגלית
9. רוחב הפטמה גדול יותר כאשר הלשון נמצאת
10. כאשר הלשון למעלה הפטמה הכי "מחוצה"
11. ככל שיש יותר מרחק בין הלשון לחך - יוצר ואקום חזק יותר

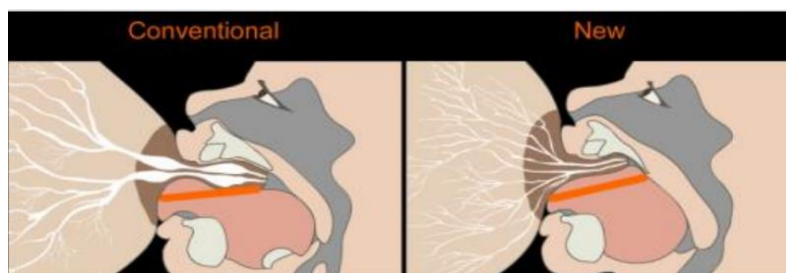


מסקנה: וואקום פנים אוראלי הוא זה שיוצר את הזרמת החלב מהשד לפה התינוק. (לא התנועה מעגלית של הלשון)

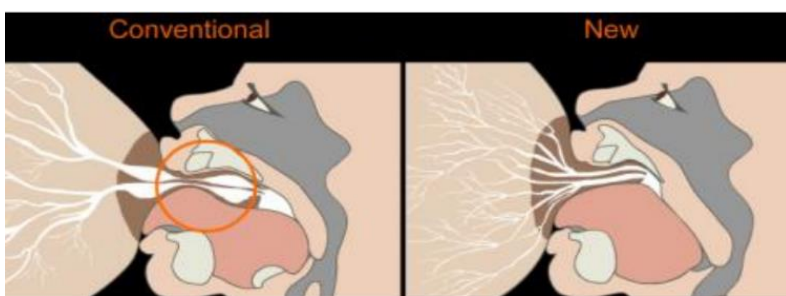


כאשר משויים את ההבנה החדשה אם מה שידוע בעבר – לוואקום יש תפקיד מרכזי בהעברת החלב.

1. הלשון לא חזה בתנועה מעגלית, החלב לא נסחט מהצינורות.



2. המחסור בתנועה מעגלית מראה שהפטמה נשארת כל הזמן באותה צורה.



נמצא שבאשר מתקיימת יניקה החלק האחורי של הלשון נדחס כלפי מטה
הלשון חזה טיפה קדימה ומושכת את החלק האחורי שלה, יורדת כלפי מטה, נוצר חלל. הפיטמה נלחצה בהתחלה ואז מתרחבת
ובחלל הסגור הזה נוצר וואקום כמו של פופמה. הלשון יורדת למטה ומגדילה את הלחץ השלילי (וואקום) בתוך החלל.
החלב מוזרק מכוח הוואקום לחלל. הלסת יורדת, הלשון עולה שוב לעבר החך ופותחת את החלל אחורה והחלב יורד הלאה
בתהליך.
החלק הקדמי של הלשון לא חז בכלל. הוא שומר על הצורה ויוצר גירוי מקומי אבל זה לא מה שחשוב.
לוואקום יש תפקיד מרכזי בהעברת חלב. אם אין וואקום אין העברה.
אם הלחיים של התינוק קורסות פנימה ואין מספיק שומן שם אז הוא מבחינתו עושה את התנועות נכון אבל הוא לא מעביר
חלב.



כשתינוק יונק לא אוכל כל הזמן – חלק מהזמן נח – ומבצע יניקות שאינם תזונתיות – דפוס של פרצי יניקה והפסקות.

יניקה תזונתית Nutritive

- זרימת חלב מלאה ומתמשכת
- הנקה לצורכי תזונה.

יניקה שאינה תזונתית Non-Nutritive

שלב ביניים בין היניקות. חלק מהזמן התינוק אוכל וחלק מהזמן נח- יניקות שנועדו לדברים אחרים- מניע את התנועה של מערכת העיכול, מפריש קצת חלב לשם הורמונים, קצת להסתכל על האם או על הסביבה, קצת להירדם. בהעדר זרימת חלב. החלב הוא פולסטיבי- יש בוסט ואז האטה וחוזר חלילה. בתוך סייקל היניקה יש גם לאם אפיזודות קטנות של ייצור חדש שלוקח שביר שניה.

- העדר זרימת חלב
- מספקת יצר בסיסי למציצה או כאמצעי הרגעה.
- קצב היניקה משתנה בהתאם למידת זרימת החלב
- מגביר פריסטולטיקה
- פריסטולטיקה – שרירים טבעתיים בוושט.
- מגביר את הפרשת מיצי העיכול
- מוריד בכי

כשמסתכלים על ציר הזמן- נחלק לשלושה שלישים
שליש ראשון בעיקר תזונתי
חלק אמצעי- קצת מזה וקצת מזה, הפסקות יותר גדולות
השליש השלישי- יותר לא תזונתיות- אני שבע, אבל בא לי קצת יניקות.
באובר סופליי אין הפוגה- אם רוצה לנוח מתנתק.

נשימה ויניקה breathing and suckling

- במחזור נורמאלי מתואם של יניקות תזונתיות, הבליעות לא מפריעות לנשימה, הנשימה ממשיכה עם מחזור המציצות.
- בתחילת הבליעה, כשהחלב נכנס ללוע, זרימת האוויר עלולה להפסק לשביר שניה ולהתחדש מיד.
- במחזור שלם של יניקה-בליעה-נשימה – תנועת הנשימה קשורה לרצף של 1:1:1
- עם המשך ההנקה מקבצי היניקה נהפכים קצרים יותר עם יותר עצירות תכופות.
- כשזרימת החלב יורדת או נעצרת, התינוק יגביר את קצה המשיכה ל-2 יניקות בשנייה ובשזרימת החלב תעלה, קצב המשיכה ירד.

הנקה הרבה יותר קלה לתינוק מבקבוק מבחינה נשימתית.

יניקה שטחית ומורידה את היציבות בחלל הפה.

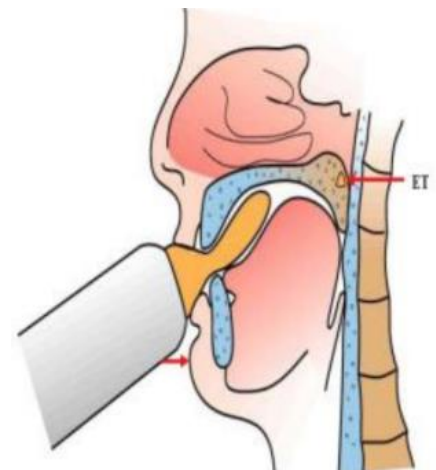
- יוצרת גומות במהלך היניקה
- תינוק ללא מספיק שומן בלחיים (פגים) – ביניקה כאשר נוצרות גומות – לא מעביר חלב.
- יש קריסה של הלחיים פנימה < מלמדים האכלת אצבע, דחיסות שד או מחכים שיגדל.
- פתיחה מוגזמת של השפה העליונה
- היווצרותם של קמטים בצידי הפה
- הימצאותם של בועיות הנקה.



תופעות המחשירות קיום קשיי בליעה- דספגיה- בזמן הארוחה

- אי שקט
- מבט מקובע
- עיניים מחפשות
- הבעה מודאגת (כיווץ מצח)
- ישנוניות בזמן הארוחה
- התעייפות מהירה
- התחלה פתאומית של קשיי אכילה

אכילה מבקבוק



הנקה - לחץ שלילי.
בקבוק - לחץ חיובי

בקבוק מלמד את התינוק בדיוק פעולה הפוכה מפעולת היניקה.
לסגור את הלסת ולא לפתוח. וגם הלשון לא צריכה לזוז.

במקום תנועה סמי מעגלית לסמקינג.
זה מה שקורה בבלבול פטמות- מיומנות הפוכה מהנקה ואז מבולבלים על השד.

בתחילת האכילה מעט לחץ חיובי.

- אם הפטמה רכה, ישתחרר חלב
- אם הפטמה נוקשה הלחץ יגרום לחלב לסגת אל חלל הבקבוק < יהיה צורך בלחץ שלילי מוגבר < כיווץ חזק של השפתיים.
- פעולת הלשון כפעולת בוכנה – תנועות חזקות קדימה ואחורה.
- התוצאה: דחיקת לשון. הלחיים נשאבות פנימה ומפעילות לחץ על החניכיים מהחוזק פנימה.

במידה שדרם החלב חזק, התינוק נאלץ להרים את גב הלשון ולחסום אותו.

- בזמן מנוחה הלשון ממשיכה ללחוץ על הפטמה של הבקבוק כדי למנוע זרימת חלב ולשמור על מיקומה בחלל הפה.
- נוצרת גבשושית לאורך כל הלשון.

ככלל,

הרמת גב הלשון בזמן יניקה יחד עם הלחץ שיוצרת פטמת הבקבוק < יכולים להשפיע עם הזמן על מבנה החך.

יניקה	בקבוק
פתיחת פה גדולה יותר כדי לתפוס את הפטמה	פתיחת פה קטנה יותר על מנת לתפוס את פטמת הגומי
שפתיים משורבבות החוצה, רגועות ונחות מסביב לשד ואוטמות אותו	שפתיים סגורות ביחד ולוחצות על מנת ליצור מגע עם פטמת הגומי
פעילות מורחבת של הלסת התחתונה - מנדיבולה	פעילות מינימאלית של הלסת התחתונה - מנדיבולה
הלשון אוזחת מסביב לפטמה, נשארת מתחתיה לאורך כל ההנקה. נעה בתנועה גלית פריסטלית מקדמת הפה אחורה.	הלשון מורמת ונלחצת קדימה כנגד קצה פטמת הגומי כדי לשלוח בזרימת החלב
שקטה למעט קול בליעות הרך.	רעש חריקה גבוה בסוף כל הכנסה של אויר לפני מציצה חדשה
יניקות יותר תכופות פר דקה	יניקות פחות תכופות



לא תזונתיות: 1 יניקה לשניה תזונתיות: 2 יניקות בשניה	
דפוס נשימה: קיצור הנשיפה, הארכת הנשיפה וקיצור השאיפה	משך האכלה משתנה, זין זמן קצר של כמה דקות לארוך +30 דקות
משך האכלה נשמך בדרך כלל 5-10 דקות	

למה לתינוקות יש בעיות יניקה

- poor latch - מיומנות חיבור לא טובה, חיבור לא תקין
- בעיות אנטומיות אורליות
- חך שסוע
- לשון קשורה
- לשון גדולה. Macroglossia
- לסת התחתונה קטנה או אחורית Microglossia
- בעיות נירולוגיות- מתח שרירים נמוך

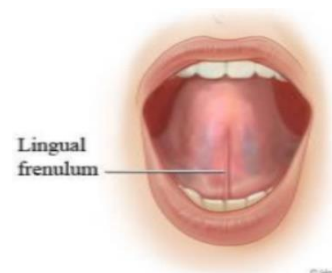
תנועת הלשון במהלך היניקה

- התארכות extension – לפיתה ומשיכה של השד במהלך החיפוש האוראלי.
- תצורה configuration – יוצרת מבנה תעלה על מנת לייצר את השד.

בעיות לשון

לשון קשורה

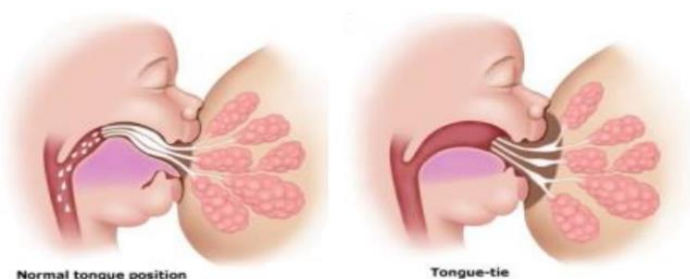
לשון קשורה Tongue-tie הינה בעיה מולדת בה הרקמה המקשרת בין הלשון לבין רצפת הפה מגבילה את התנועה התקינה של הלשון.



בתוצאה מכך מתקצר טווח התנועה של הלשון ומיומנות כמו יניקה עלולות להפגע.

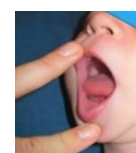
סימנים ללשון קשורה:

1. חוסר ניקוז – חוסר עליית משקל תינוק
2. כאב בשדיים
3. שד לא מתנקז כמו שצריך – גודשים



חוסר יכולת להוציא את הלשון

Restricted extension - הוצאת הלשון מחוץ לקו החניכיים הכרכית בזמן יניקה, זאת על מנת למנוע מצב של הפעלת רפלקס הנשיכה.



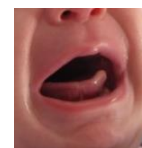
Restricted elevation – היכולת להניע את הלשון כלפי מעלה.

יכולת זו נבחנת כשתינוק בוכה אמור לעלות את הלשון עד למעלה, לנגוע בחך כאשר הפה חצי פתוח.



Grooving/cupping – צידי הלשון אמורים לעלות בצורת תעלה ובכך להקיף את הפטמה, לייצבה בפה ולסייע בבליעה.

אצל ילדים עם לשון קשורה יש מצבים שהמיתר מספיק אלסטי המאפשר את ה grooving



Lateralization – היכולת להניע את הלשון מצד לצד. יותר חשוב באכילת מזון מוצק, מאפשר מעבר מזון למרכז הלשון ומנקה את חלל הפה.

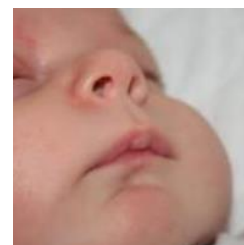


Lip retraction – מעיד על טונוס שפתיים נמוך. מיתר עליון קשור.



בועיות הנקה

- חולשה בשפתיים
- יניקה לא אפקטיבית
- Lip retraction
- לשון קשורה
- Overuse of lips



הערכת תנועתיות של הלשון

בדיקת יכולת מציצה



הדרך הטובה ביותר להערכת התנועתיות היא באמצעות מציצה של האצבע. כאשר יש נוזל יש תינוקות שיונקים באופן טוב ואפקטיבי.



באמצעות מכשיר craved tip syringes

עיסוי לשון

- תינוקות עם לשון קשורה מתקשים לפעמים להוריד את הלשון כלפי מטה.
- גירוי קצה הלשון עם האצבע יכול לסייע להם להוריד את הלשון
- כדאי לעשות זאת תוך כדי הנקה.



- לגרות את השפתיים על מנת לעודד פתיחה
- החלקי את האצבע לתוך הפה לאורך החך
- אפשרי לתינוק למצוץ מספר שניות
- משכי את האצבע כאשר עדין יש וואקום
- הורדי את הלשון כלפי מטה



עידוד הוצאת לשון

- לגרות את השפה התחתונה
- להעביר את האצבע מצד לצד על החך התחתון

